

CRISES HIPERTENSIVAS



ROTINA CLÍNICA

Modelos de evolução

PA MUITO ELEVADA SEM LESÃO DE ÓRGÃO-ALVO

- **HDA:**

PACIENTE RELATA SINTOMAS DE SÍNDROME GRIPAL (CORIZA, TOSSE, RINORREIA, DESCRIVER EM DETALHES). NEGA CEFALÉIA INTENSA/DOR TORÁCICA/DISPNEIA SÚBITA OU OUTROS SINTOMAS.

OS SINTOMAS SE INICIARAM HÁ CERCA DE X MINUTOS.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES: NEGA/REFERE HAS, IAM, DAOP OU AVE PRÉVIOS

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



ROTINA CLÍNICA

PA MUITO ELEVADA SEM LESÃO DE ÓRGÃO-ALVO

GERAL: REG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL.

NEURO: LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

AR: MVF+, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O₂: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

ACV: RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

ABD: ATÍPICO, RHA PRESENTES NOS 4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL.

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



HD E CONDUTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

PRESSÃO ARTERIAL MUITO ELEVADA SEM LESÃO DE ÓRGÃO-ALVO.

- **CONDUTAS:**

- PRESCREVO ANTI-HIPERTENSIVO VIA ORAL AGORA.
- INICIO ANTI-HIPERTENSIVOS PARA USO DOMICILIAR.
- ORIENTO ACOMPANHAMENTO PRESSÓRICO AMBULATORIAL.
- ORIENTO SINAIS DE ALARME E, EM CASO DA PRESENÇA DESTES, PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO IMEDIATAMENTE.



ANAMNESE: EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE CEFALeia INTENSA/DOR TORÁCICA/DISPNEIA SÚBITA ASSOCIADO A MAL ESTAR, NAUSEAS, VÔMITOS E SUDORESE.

OS SINTOMAS INICIARAM HÁ CERCA DE X MINUTOS.

RELATA EPISÓDIO SIMILAR OCORRIDO HÁ X MESES.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES: NEGA/REFERE IAM, DAOP OU AVE PRÉVIOS

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



EF: EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA

GERAL: REG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL.

NEURO: LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

AR: MVF+, SEM RUÍDOS ADVENTÍCIOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O₂: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO, FR: IRPM

ACV: RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

ABD: ATÍPICO, RHA PRESENTES NOS 4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO PERITONEAL.

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



HD E CONDUTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

EMERGÊNCIA HIPERTENSIVA - SÍNDROME CORONARIANA AGUDA? ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO? DISSECÇÃO AGUDA DE AORTA? (ATENTAR PARA DIFERENÇA DE PA ENTRE MMSS, SOBRETUDO $SE \geq 20$ mmHg).

- **CONDUTAS:**

- TRANSFIRO PACIENTE PARA A SALA DE EMERGÊNCIA.
- INICIO ANTI-HIPERTENSIVO ENDOVENOSO.
- SOLICITO EXAMES COMPLEMENTARES.
- ENTRO EM CONTATO COM O SERVIÇO DE REFERÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO ETIOLÓGICA.
- MANTENHO PACIENTE SOB VIGILÂNCIA E MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA.

